

NS 22231568092/065

MARCO ANTONIO DOS SANTOS GARCIA

Estudante

IDADE: 24 PESO: 105 ALTURA: 176 PROFISSÃO: aux. tec. instrument.

SINTOMAS: Ronco; cansaço; restrição de exp. torácica

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Metilfelidato (pl concentração)

MÉDICO: Dr. Ivan

EXERCÍCIO FÍSICO: não.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: S

HORA QUE DORME: 00:30 HORA QUE ACORDA: 6:00

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO (X) EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: III IAH: 66, 2 SPO2: 81%
medida - 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (M) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Rinite

06/10 Avaliação

11/10 P = 7.2 cmH₂O * Principal - 6cmH₂O.
IAH = 4.4 e/ev
M. de uso: 6h.
Jua.

27/10 P = 7.2 cmH₂O Relata estar cf def. pl
23 IAH = 3.4 e/ev respirar pela narina
M. de uso: 4:44 (E) Jua.

18/12 P = 7.2 cmH₂O Bem adapt.
23 IAH = 2.5 e/ev
M. de uso: 5h30'
Fuga = 1.7 e/min.
Jua

08/04 P = 7.2 cmH₂O
24 IAH = 1.9 e/ev
M. de uso: 6h52'
Fuga = 1.2 e/lpm.
Jua.

10/06 P = 7.2 cmH₂O
24 IAH = 1.8 e/ev
M. de uso: 7:30 e/pm.
Fuga = 2.0
Jua.

18/09 P = 7.2 cmH₂O
24 IAH = 1.5 e/ev
M. de uso: 7h34'
Jua

21/01/25 Pte deixou aparelho para
manutenção devido a lavulha
Natacha

15/07/25 Retornou Aparelho manutenção.

P: 7,2 cm H₂O Fixe
P: rampa G, 8 cm H₂O.
APE 2 rampa
unif. 3

* horou máx N30i (M) *

Silvia

11/08 P = 7,2 cm H₂O

25 IAH = 1,2 e/h

mdc in: 7h 30'

fuga: 2,2 e/m

Bem adaptada

Natacha



**Labinas
Ranna
e Arrais**

clínica médica

MARCO ANTONIO DOS SANTOS GARCIA

Encaminhamento para adaptação e uso de CPAP

**Dr. Carlos Henrique
Labinas de Oliveira**
Otorrinolaringologista
CRM/SP 67.843
RQE nº 17.731

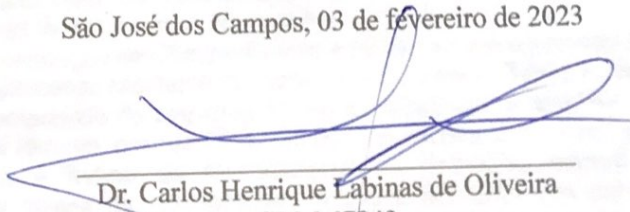
HD SAHOS

**Dr. Cesar Augusto
Ranna Araújo**
Endocrinologista
CRM/SP 62.911
RQE nº 17.257

**Dra. Claudia
Arrais Araújo**
Pediatra
CRM/SP 62.912
AMIB 104267

**Telma Lúcia Paludeto
Parizzi de Oliveira**
Fonoaudióloga
CRFª/SP 5.623

São José dos Campos, 03 de fevereiro de 2023


Dr. Carlos Henrique Labinas de Oliveira
CRM 67843



@labinasrannaearrais

www.labinasrannaearrais.com.br

Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 - Ed. Madison Tower, sala 501
Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP
[12] 3941-8191 / 3922-0365 / 3941-8518
CEP: 12246-000

CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Marco Antonio dos Santos Garcia
EXAME nº: 5225-2 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Carlos Henrique Labinas de Oliveira
DATA: 16/01/2023
IDADE: 23 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h34min e concluído às 05h59min. A latência para o sono foi de 5 minutos e a latência para o estágio REM, de 94 minutos. O tempo total de sono foi de 368 minutos (06h08min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 95,5%. A distribuição do sono mostrou 9,9% de estágio 1, 40,5% de estágio 2, 35,1% de estágio 3 e 14,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 12,5 minutos em vigília, ocorreram 57 microdespertares (Índice: 9,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.
O índice de apneia/hipopneia foi de 4,7/hora, sendo 1,1 apneia/hora e 3,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 4,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 93% e a mínima de 85%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 6,8 cm H₂O.

Os índices de apneia/hipopneia (4,7/hora; normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (4,7/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Registraram-se poucos episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina e o ritmo cardíaco foi sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 68 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.
O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 5 min; normal até 30 min) – ele ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 23h00min. A latência para o estágio REM estava normal (94 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (95,5%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,3/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (9,9%; normal: 5%) e 3 (35,1%; normal: 15-20%), e a redução dos estágios 2 (40,5%; normal: 45-55%) e REM (14,5%; normal: 20-25%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 69.730

CRM-SP 62.856

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Marco Antonio dos Santos Garcia
EXAME nº: 5225
SOLICITADO POR: Dr. Ivan Senis Cardoso Macedo
DATA: 24/09/2022
IDADE: 23 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h49min e concluído às 06h39min. A latência para o sono foi de 0 minuto e a latência para o estágio REM, de 99 minutos. O tempo total de sono foi de 454 minutos (07h34min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 96,3%. A distribuição do sono mostrou 23,6% de estágio 1, 44,6% de estágio 2, 9,8% de estágio 3 e 22% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 17,5 minutos em vigília, ocorreram 281 microdespertares (índice: 37,1/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 66,2/hora, sendo 33,2 apneia/hora e 33 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 66,2/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 83% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (66,2/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (66,2/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 68 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu imediatamente (latência para o sono: 0 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (99 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (96,3%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 37,1/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (23,6%; normal: 5%) e a redução do estágio 3 (9,8%; normal: 15-20%). As porcentagens dos estágios 2 (44,6%; normal: 45-55%) e REM (22%; normal: 20-25%) permaneceram nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 11 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730